

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 3, Salah Bounider
Faculté de médecine de Constantine

Module de gastro-entérologie

Travail dirigé
4^{ème} année médecine

Conduite à tenir devant un ictère

Dr Abderraouf BATAICHE
Maitre-assistant en chirurgie générale
EH. Didouche Mourad

Année universitaire 2025 – 2026

Plan :

1. Intérêt
2. Objectifs pédagogiques
3. Rappel anatomique
4. Définition
5. Physiopathologie
 - 5.1.Métabolisme de la bilirubine
 - 5.2.Mécanisme de l'ictère
 - 5.2.1. Ictère à bilirubine non conjuguée (bilirubine indirecte)
 - 5.2.2. Ictère à bilirubine conjuguée (bilirubine directe)
6. Etiologie
 - 6.1.Ictère à bilirubine non conjuguée
 - 6.1.1. Hyperproduction
 - 6.1.2. Diminution de la captation
 - 6.1.3. Défaut de conjugaison
 - 6.2.Ictère à bilirubine conjuguée
 - 6.2.1. Hépatocellulaire
 - 6.2.2. Cholestase intrahépatique
 - 6.2.3. Cholestase extra hépatique
 - 6.2.4. Ictère a bilirubine conjuguée sans cholestase
7. Démarche diagnostique
 - 7.1.Examen clinique
 - 7.1.1. Interrogatoire ciblé
 - 7.1.2. Examen physique
 - 7.1.3. Signes d'alarmes
 - 7.2.Examen biologique
 - 7.2.1. Examens biologiques de 1^{ère} intention
 - 7.2.2. Examens biologiques de 2^{ème} intention
 - 7.3.Examen morphologique
8. Traitement :
 - 8.1. Prise en charge des urgences
 - 8.2.Traitement symptomatique
 - 8.3.Traitement étiologique

1. INTERET DE LA QUESTION :

- Motif fréquent de consultation (aux urgences ou non)
- Divers étiologies
- Démarche diagnostique précise

2. OBJECTIF PEDAGOGIQUE :

- Définir l'ictère
- Connaitre les différentes étiologies
- Savoir adopter une démarche diagnostique

3. RAPPEL ANATOMIQUE :

Le foie, situé dans l'hypochondre droit et l'épigastre, est divisé en deux lobes fonctionnels (droit et gauche), et segmenté en 8 unités indépendantes. Il reçoit une double vascularisation afférente : la veine porte (75% du débit, apport nutritif) et l'artère hépatique propre (25%, apport en oxygène). Le drainage veineux se fait par les trois veines sus-hépatiques vers la veine cave inférieure. Au hile hépatique, la voie biliaire est antérieure, l'artère hépatique médiale et la veine porte postérieure, repère essentiel pour éviter les lésions iatrogènes.

La bile, produite par les hépatocytes, circule dans les canalicules biliaires intra-hépatiques, puis converge vers les canaux hépatiques droit et gauche, qui s'unissent pour former le canal hépatique commun. Celui-ci rejoint le canal cystique (issu de la vésicule biliaire, réservoir de 30-50 mL situé dans la fosse cystique) pour constituer la voie biliaire principale (cholédoque), longue de 6-8 cm et de diamètre normal ≤ 6 mm. Le cholédoque traverse quatre portions (supraduodénale, rétro-duodénale, pancréatique, intra-duodénale) avant de s'aboucher dans le duodénum (D2) au niveau de l'ampoule de Vater, régulée par le sphincter d'Oddi.

4. DEFINITION :

C'est la coloration jaune de la peau et des muqueuses, secondaire à l'accumulation tissulaire de bilirubine consécutive à une hyperbilirubinémie sérique.

Bilirubinémie normale : < 1 mg/dL, soit < 17 μ mol/L

Seuil de visibilité clinique : 2 à 3 mg/dL, soit 34 à 51 μ mol/L, avec une variabilité selon :

- Le type de bilirubine (conjuguée légèrement visible plus précocement)
- La pigmentation cutanée et le site d'examen (sclérotique en premier)
- L'expérience de l'examineur et les conditions d'éclairage

Premier signe visible : ictère scléral, souvent perceptible dès ~ 34 à 40 μ mol/L chez un observateur entraîné

- **Consensus fort :**
Seuil ≈ 2 mg/dL (≈ 34 μ mol/L) $\rightarrow$ ictère scléral
- **Ictère cutané franc :**
Plutôt $> 2,5$ à 3 mg/dL (≈ 43 à 51 μ mol/L)

5. PHYSIOPATHOLOGIE :

5.1. Métabolisme de la bilirubine :

Le métabolisme de la bilirubine passe par 4 principales étapes.

Etape sanguine du métabolisme de la bilirubine : La bilirubine non conjuguée (BNC) provient principalement (80-85 %) du catabolisme de l'hème issu de la dégradation physiologique des globules rouges sénescents par le système réticulo-endothélial (rate, foie, moelle). La BNC est lipophile et peu soluble dans l'eau ; elle circule donc liée de façon réversible à l'albumine. De ce fait, la BNC ne peut franchir la barrière glomérulaire rénale, par sa liaison à l'albumine (masse moléculaire élevée) et son caractère non hydrosoluble.

Etape hépatocytaire du métabolisme de la bilirubine : Dans le cytoplasme hépatocytaire, la bilirubine est liée à d'autres protéines et est acheminée vers le réticulum endoplasmique où l'enzyme UDP-glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1). La conjugaison produit principalement de la bilirubine diglucuronide (~70-80 %) et accessoirement de la monoglucuronide (~20-30 %), même en conditions physiologiques. Le transport canaliculaire de la bilirubine conjuguée est assuré par le transporteur MRP2 (ABCC2), dépendant de l'ATP.

Etape de sécrétion de la bilirubine : La bile est un mélange complexe : eau, électrolytes, acides biliaires, cholestérol, phospholipides, bilirubine conjuguée, et protéines.

La bilirubine conjuguée est sécrétée activement dans le canalicule biliaire via MRP2, indépendamment des acides biliaires (voies de sécrétion distinctes).

Etape intestinale : Les bactéries du côlon déconjuguent puis réduisent la bilirubine en urobilinogène.

Destin de l'urobilinogène :

~80-90 % → oxydé en stercobiline (pigment brun des selles)

~10-20 % → réabsorbé → cycle entéro-hépatique (reprise hépatique et ré-excrétion biliaire)

<1 % → élimination urinaire sous forme d'urobiline (jaune des urines)

5.2. Mécanisme de l'ictère :

En fonction de la fraction prédominante de la bilirubine on distingue deux types d'ictère :

5.2.1. Ictère à bilirubine non conjuguée (bilirubine indirecte) :

Secondaire à :

Surproduction de la bilirubine qui dépasse le pouvoir de conjugaison de la cellule hépatique.

Défaut de captation de la bilirubine par la cellule hépatique.

Défaut de conjugaison par la cellule hépatique.

5.2.2. Ictère à bilirubine conjuguée (bilirubine directe) :

➤ Cholestase :

Définition :

La cholestase est définie par la diminution de la sécrétion biliaire et non par la stagnation de la bile »

Mécanisme :

Les obstacles des voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques

Atteinte des transporteurs canaliculaires (MRP2, BSEP), Destruction des canaux biliaires, Infiltration hépatique.

Retentissement :

- couleur foncée des urines
- Prurit (La rétention des sels biliaires)
- cirrhose biliaire secondaire
- accumulation de cuivre intrahépatocytaire (par défaut d'élimination biliaire de ce métal).
- décoloration de selles.
- Malabsorption (Le déficit en acides biliaires est responsable à long terme)
 - La malabsorption des graisses entraîne une stéatorrhée et un amaigrissement.
 - La malabsorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K) entraîne des troubles de la coagulation.
 - La malabsorption du calcium entraîne une ostéodystrophie.

➤ Non cholestatique :

L'ictère est dû à une hyperbilirubinémie conjuguée bénigne, sans cholestase vraie ni atteinte hépatique structurelle.

Dubin-Johnson : défaut d'excrétion biliaire (MRP2) → accumulation intra-hépatocytaire → reflux sanguin

Rotor : défaut de recaptage/storage hépatique (OATP1B1/1B3) → fuite systémique de bilirubine

➤ Ictère a mécanisme multiples :

L'ictère ne relève pas d'un seul des mécanismes précédents mais d'une conjonction de différents facteurs. Se voit en réanimation chez des malades dans un état grave.

Sepsis : hémolyse microangiopathique (incst) + cholestase de sepsis + dysfonction hépatocytaire

Insuffisance cardiaque droite : congestion hépatique (hypoxie) + cholestase congestive

Hépatite alcoolique aiguë : nécrose hépatocytaire + cholestase intra-hépatique + possible hémolyse associée

6. ETIOLOGIE :

6.1. Ictère a bilirubine non conjuguée :

6.1.1. Hyperproduction :

- Hémolyse (drépanocytose, déficit en G6PD, anémies auto-immunes).
- Résorption d'hématomes importants.
- Érythropoïèse inefficace (thalassémie, anémie sidéroblastique).

6.1.2. Diminution de la captation :

- Insuffisance cardiaque droite (congestion hépatique réduisant le flux sanguin)
- Médicaments compétitifs pour transporteurs hépatiques : rifampicine, probénécide, chloramphénicol
- Jeûne prolongé : réduction de la ligandine/Y-protéine, transport intracellulaire.
- Shunts portosystémiques congénitaux ou acquis : la bilirubine contourne le foie.

6.1.3. Défaut de conjugaison :

- Syndrome de Gilbert :
Déficit partiel en UGT1A1, prévalence 5-10%
ictère intermittent, bénin, favoriser par le jeûne, le stress, la déshydratation et l'infection
- Syndrome de Crigler-Najjar type I/II (déficit complet/partiel en UGT1A1)
- Médicaments inhibiteurs de l'UGT1A1 : éthinyloestradiol
- Hypothyroïdie congénitale/néonatale : retard de maturation enzymatique.

6.2. Ictère a bilirubine conjuguée :

6.2.1. Hépatocellulaire :

Catégorie	Étiologies validées
Infectieuses	Hépatites virales A, B, C, D, E Infections à CMV, EBV, HSV chez l'immunodéprimé
Toxiques / Médicamenteuses	Paracétamol (surdosage) Isoniazide, amiodarone, statines, AINS Toxines : Amanita phalloïdes, tétrachlorure de carbone
Alcooliques	Hépatite alcoolique aiguë Cirrhose alcoolique décompensée
Auto-immunes	Hépatite auto-immune (types 1 et 2) Cholangite biliaire primitive
Métaboliques / Génétiques	Maladie de Wilson (surcharge en cuivre) Hémochromatose héréditaire Déficit en alpha-1-antitrypsine Stéatohépatite non alcoolique (NASH)

Ischémiques	Hépatite ischémique (« shock liver ») Syndrome de Budd-Chiari (thrombose des veines sus-hépatiques)
--------------------	--

6.2.2. Cholestase intrahépatique :

Catégorie	Étiologies validées
Médicamenteuses	Amoxicilline/acide clavulanique (cause fréquente) Stéroïdes anabolisants, contraceptifs oraux Chlorpromazine, phénothiazines Alcaloïdes de pyrrolizidine (phytothérapie)
Inflammatoires / Auto-immunes	Cholangite sclérosante primitive Cholangite biliaire primitive Sarcoïdose hépatique, amylose
Infiltratives	Lymphome, leucémie, métastases hépatiques Tuberculose hépatique
Grossesse	Cholestase gravidique (3 ^e trimestre) Stéatose hépatique aiguë gravidique (urgence)
Post-opératoires / Sepsis	Cholestase post-opératoire bénigne Cholestase du sepsis sévère

6.2.3. Cholestase extra hépatique :

Étiologie	Fréquence / Contexte
Lithiase cholédocienne	Cause la plus fréquente d'ictère obstructif chez l'adulte
Cancer de la tête du pancréas	Ictère indolore progressif chez sujet > 60 ans
Cholangiocarcinome	Voies biliaires intra- ou extra-hépatiques
Sténose biliaire post-chirurgicale	Après cholécystectomie ou chirurgie biliaire
Angiocholite aiguë	Triade de Charcot : fièvre + douleur + ictère (urgence)
Pancréatite chronique / pseudokyste	Compression extrinsèque de la voie biliaire
Adénopathies compressives	Lymphome, métastases du hile hépatique
Parasitoses biliaires	Ascariose,....

6.2.4. Ictère à bilirubine conjuguée sans cholestase :

Syndrome de Dubin-Johnson :

- Déficit en MRP2 (transporteur canaliculaire ABCC2)
- Foie noir macroscopiquement, coproporphyrinurie de type I
- Ictère chronique intermittent, bénin

Syndrome de Rotor :

- Déficit en OATP1B1/OATP1B3 (transporteurs sinusoidaux SLCO1B1/1B3)
- Coproporphyrinurie de type III
- Ictère chronique bénin, foie de couleur normale

7. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE :

7.1. Examen clinique :

7.1.1. Interrogatoire ciblé :

Antécédents :

- **Personnels** : lithiase biliaire, prise médicamenteuse, éthyliste, notion de voyage, transfusion sanguine, chirurgie biliaire
- **Familiaux** : ictère familial, hémolyse, syndrome de Gilbert

Mode de début : brutal ou progressif

Évolution : ancien, récidivant ou premier épisode

Signes associés :

- douleur biliaire
- fièvre
- prurit (orientant vers une cholestase)
- amaigrissement
- altération de l'état général (AEG)

Coloration des selles et des urines

Recherche de signes de gravité

Orientation diagnostique après interrogatoire

Ictère à bilirubine non conjuguée :

Urines claires, absence de prurit

Antécédents d'hémolyse, anémie → **hyperhémolyse**

Ictère fluctuant, déclenché par le jeûne ou le stress → **syndrome de Gilbert**

Ictère à bilirubine conjuguée (cholestase) :

Urines foncées, selles décolorées, prurit

Douleurs + fièvre → **lithiase biliaire / angiocholite aiguë**

Amaigrissement + ictère indolore → **étiologie tumorale** (pancréas, voies biliaires)

Prise médicamenteuse récente → **hépatite médicamenteuse ou cholestase médicamenteuse**

Antécédents auto-immuns → **cholangite biliaire primitive** (anciennement CBP)

7.1.2. Examen physique :

Signes vitaux et état général :

- Recherche de fièvre, tachycardie, hypotension
- Asthénie, anorexie, amaigrissement

Examen cutané et muqueux :

- Ictère cutanéomuqueux
- Lésions de grattage (prurit)
- Xanthomes, xanthélasmas
- Angiomes stellaires, érythème palmaire
- Ecchymoses, pétéchies, purpura (troubles de l'hémostase)

Examen abdominal :

- **Inspection** : circulation veineuse collatérale, distension abdominale, cicatrices chirurgicales
- **Palpation** : hépatomégalie, splénomégalie, vésicule palpable (signe de Courvoisier), masse abdominale
- **Percussion** : matité des flancs (ascite)
- **Toucher rectal** : méléna, rectorragies (HTP, tumeur digestive...)

Examen extra-abdominal :

- Adénopathies
- Œdèmes des membres inférieurs
- Troubles neurologiques (encéphalopathie hépatique)

7.1.3. Signes d'alarmes :

Signe	Evoqué
Fièvre	Angiocholite aigue
Hypotension + tachycardie	Choc septique ou hémorragique
Trouble de la conscience	Encéphalopathie hépatique
Hémorragie digestive	Hypertension portale
Pétéchie, purpura	Insuffisance Hépatique sévère
Ictère progressif + Altération de l'état générale	Etiologie tumorale
Ictère d'installation rapide + AEG	Hépatite aigue sévère / fulminante

7.2. Examen biologique :

7.2.1. Examens biologiques de 1^{ère} intention :

Paramètre	Objectif	Interprétation clé
Bilirubine totale + fractionnée (conjuguée/libre)	Typage de l'ictère (étape fondamentale)	• Non conjuguée prédominante (>80%) → hémolyse, Gilbert, Crigler-Najjar • Conjuguée prédominante → cholestase ou atteinte hépatocellulaire

Transaminases (ASAT/ALAT)	Evaluer la cytolysé hépatocytaire	• ALT > AST : hépatite virale, toxique, auto-immune • AST/ALT > 2 : hépatite alcoolique • > 10×N : hépatite aiguë sévère, ischémique, toxique
Phosphatases alcalines (PAL) + γ-GT	Confirmer et caractériser la cholestase	• PAL ↑ + GGT ↑ = cholestase d'origine hépatique • PAL ↑ + GGT normale = origine osseuse ou autre (grossesse, enfant)
TP + Facteur V	Evaluer la fonction de synthèse hépatique	• TP bas isolé : carence en Vit K, cholestase • TP + Facteur V bas : insuffisance hépatocellulaire sévère (urgence)
Albuminémie	Fonction de synthèse chronique	Baisse (<35 g/L) = maladie chronique (cirrhose)
NFS	Rechercher une hémolyse	• Réticulocytes ↑ + Hb ↓ + haptoglobine effondrée = hémolyse active • Haptoglobine normale exclut quasi-totalement une hémolyse

Dans l'Ictère à bilirubine conjugué non cholestatique, les phosphatases alcalines et la γ -GT ne sont pas augmentées.

7.2.2. Examens biologiques de 2^{ème} intention :

➤ Ictère a bilirubine non conjuguée :

Examen	Indication	Précision / piège
Test de Coombs direct	Hémolyse auto-immune suspectée	Positif = anticorps anti-érythrocytaires
Électrophorèse de l'hémoglobine	Hémoglobinopathie (drépanocytose, thalassémie)	Réalisé en période stable (pas pendant une crise vaso-occlusive aiguë)
Dosage de la G6PD	Déficit en G6PD suspecté	peut-être faussement normal pendant la crise hémolytique (les réticulocytes ont une activité enzymatique préservée) → répéter à distance
Test de jeûne (rarement utilisé)	Syndrome de Gilbert	Aggravation de l'ictère après 24-48h de jeûne remplacé en pratique par le génotypage UGT1A1 si nécessaire
Génotypage UGT1A1 (ajout moderne)	Confirmation du syndrome de Gilbert ou Crigler-Najjar	Plus fiable que le test de jeûne, utile en cas de doute diagnostique

➤ **Ictère a bilirubine conjuguée :**

Catégorie	Examens	Interprétation/orientation
Sérologies virales	• IgM anti-VHA • Ag HBs, IgM anti-HBc • Ac anti-VHC + ARN VHC • IgM anti-VHE	• IgM anti-VHA / IgM anti-VHE → infection aiguë • Ag HBs + IgM anti-HBc → hépatite B aiguë • Ac anti-VHC + ARN VHC positif → infection active
Auto-anticorps	• Ac anti-mitochondries (AMA-M2) • ASMA (anti-muscle lisse) • Anti-LKM1 • p-ANCA	• AMA-M2+ → cholangite biliaire primitive • ASMA ou LKM1+ → hépatite auto-immune • p-ANCA+ + MICI → cholangite sclérosante primitive
Bilan métabolique	• Ferritine, CST • Cuivre, céruléoplasmine • Alpha-1-antitrypsine	• CST > 45 % + ferritine ↑ → hémochromatose • Cuivre ↓ + céruléoplasmine ↓ → maladie de Wilson • Alpha-1-AT ↓ → déficit (cirrhose/emphysème)
Marqueurs tumoraux	• AFP • ACE • CA 19-9	• AFP ↑ → carcinome hépatocellulaire • CA 19-9 ↑ → cholangiocarcinome / cancer pancréatique - Peut ↑ en cholestase bénigne
Lipase	• Lipase sérique	• > 3× normale → pancréatite aiguë → possible ictère par compression biliaire
Bilan thyroïdien (optionnel)	• TSH • T4 libre	• Hypothyroïdie sévère → hyperbilirubinémie non conjuguée

7.3. Examens morphologiques :

L'exploration morphologique de l'ictère repose sur une stratégie séquentielle. L'échographie abdominale constitue l'examen de première intention : rapide, non irradiante et peu coûteuse, elle recherche une dilatation des voies biliaires (signe d'obstacle) et une lithiasie. En cas de doute ou de voies biliaires non dilatées, la cholangio-IRM permet une visualisation précise de l'arbre biliaire sans invasivité. Le scanner injecté est réservé à la suspicion de lésion tissulaire et au bilan d'extension tumoral. L'écho-endoscopie offre une haute résolution pour les lésions de petite taille et permet des biopsies guidées. Enfin, la CPRE n'a plus qu'une place thérapeutique (extraction de calculs, drainage biliaire), son risque de pancréatite (5-10%) contre-indiquant son usage purement diagnostique.

Examen	Indication	Avantages	Limites
Échographie	• 1^{re} intention systématique • Urgence (douleur + fièvre + ictère) • Recherche de : dilatation des voies biliaires, lithiase vésiculaire/cholécystite, tumeur, masse, ascite	• Non irradiant, non invasif • Rapide, disponible, peu coûteux • Sensible pour la dilatation des VB et les calculs vésiculaires • Guidage pour ponctions/biopsies	• Opérateur-dépendant • Limité par : gaz intestinaux, obésité, météorisme • Peu sensible pour les calculs du cholédoque distal et les lésions papillaires
Scanner injecté	• Suspicion de tumeur pancréatique, cholangiocarcinome, métastases	• Rapide, largement disponible • Excellente analyse du pancréas, des ganglions, des métastases	• Irradiant • Produit de contraste iodé : risque d'allergie et de néphrotoxicité • Moins performant que l'IRM pour l'arbre biliaire non dilaté
Cholangio-IRM	• Caractérisation d'un obstacle biliaire non vu à l'échographie • Caractérisation d'une lésion hépatobiliaire • Suspicion de cholangite sclérosante primitive (CSP)	• Non invasif, non irradiant • Excellente visualisation de l'arbre biliaire (intra- et extra-hépatique) • Analyse du parenchyme hépatique et pancréatique en même temps	• Coûteux, disponibilité limitée • Contre-indications : pacemaker, clips métalliques non compatibles, claustrophobie • Durée d'examen longue (30-45 min)
Écho-endoscopie	• Lithiase de la voie biliaire principale (VBP) de petite taille (<5 mm) • Lésions papillaires, ampullomes • Caractérisation d'une masse pancréatique ou biliaire • Staging tumoral (envahissement local, adénopathies)	• Haute résolution des structures péri-digestives • Permet des biopsies/ponctions guidées	• Invasif, nécessite sédation profonde ou anesthésie générale • Nécessite une expertise technique • Disponibilité limitée aux centres spécialisés • Risques rares : perforation, saignement, pancréatite
CPRE	• Visée thérapeutique quasi-exclusive aujourd'hui • Extraction de lithiase cholécystique • Drainage biliaire (prothèse/stent) en cas	• Permet diagnostic + traitement en un temps • Gestes possibles : sphinctérotomie, extraction de calculs, pose de prothèse,	• Invasif, nécessite anesthésie/sédation • Risque de pancréatite post-CPRE : 5-10% (parfois sévère) • Autres risques : perforation, hémorragie, cholangite • Échec technique possible

	d'obstacle • Biopsies de lésions papillaires ou biliaires	dilatation de sténose	(anatomie difficile, antécédents chirurgicaux)
--	---	-----------------------	---

8. TRAITEMENT :

8.1. Prise en charge des urgences :

- **Angiocholite aiguë** (fièvre + douleur + ictère)
→ Antibiothérapie IV probabiliste en urgence + drainage biliaire rapide (CPRE)
- **Hépatite fulminante** (TP < 50 % + encéphalopathie)
→ Transfert en réanimation + évaluation en vue d'une transplantation hépatique
- **Hémolyse aiguë sévère**
→ Transfusion si nécessaire + traitement étiologique (arrêt du médicament en cause, immunosuppresseurs si origine auto-immune)
- **Obstruction biliaire maligne compliquée de cholangite**
→ Drainage biliaire (endoscopique par prothèse ou radiologique) + antibiothérapie IV

8.2. Traitement symptomatique :

- **Prurit cholestatique**
→ 1^{re} ligne : résines échangeuses d'ions (cholestyramine)
→ 2^e ligne : rifampicine, naltrexone, sertraline
→ Mesures associées : soins cutanés, émollients, ongles courts
- **Troubles de la coagulation (TP abaissé)**
→ Vitamine K IV en cas de cholestase (malabsorption des vitamines liposolubles)
- **Dénutrition / malabsorption**
→ Supplémentation en vitamines liposolubles (A, D, E, K) + adaptation nutritionnelle
- **Encéphalopathie hépatique**
→ Lactulose + rifaximine
→ Traitement du facteur déclenchant (infection, hémorragie digestive, constipation...)

8.3. Traitement étiologique :

Le traitement de l'ictère est avant tout **étiologique**.

il repose sur la prise en charge de la cause sous-jacente (levée d'un obstacle biliaire, arrêt d'un médicament hépatotoxique, traitement antiviral, immunosuppression, sevrage alcoolique...).

L'ictère constitue un **symptôme** et non une cible thérapeutique en soi.